

INDICADO POR: Drº Pedro Macêdo

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

VALTER GONÇALVES

IDADE: 68 PESO: 84 ALTURA: 170 PROFISSÃO: IMOBILIÁRIA

SINTOMAS: cansaço excessivo / pernas inchadas

QUEIXAS: esquecimento

MEDICAMENTOS: Glifazina / Rosuvastatina

MÉDICO: Drº Pedro

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 (19) JANTAR: —

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILHO: () S (X) N 15' DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE esposa

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N às vezes

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 39 cm

OVERLAP: não

MALLAMPATI: III

IAH: 26.3 SPO2: 70% / 84% do sono

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: nega

Nariz tam (M).

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS

(S) ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N

SPO2 C/ CPAP: —

PRESSÃO NO EXAME: —

09/05/25 Avaliação

16/05/25 P = 5.8 cmH₂O

IAH = 2.5 e 1h

m. de uso: 4h23'

Sem adaptado.

↓ P = 4-7 cmH₂O.

fua

23/05 P = 6.2 cmH₂O

25 IAH = 1.7 e 1h

m. de uso: 3h.

fua

06/06 Foi trocado CPAP p/ Dream Station

25

11/06 - Coloco a masc. Pico p/ teste, mas sem sucesso.

25 - P = 5.8 cmH₂O

IAH = 3.0 e 1h

fua

10/07 Coloco masc. Nasal D. wisp, p/ teste.

25 P = 5.8

m. de uso: 2h conseguiu id. 5h28'

fua



Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo

Neurologista e Neurofisiologista / CRM: 204.363/SP - RQE: 79944

Nome: Valter Gonçalves

CPF: Não há CPF cadastrado

Solicito:

Realização de cpap ao dormir.

Paciente apresentando SAHOS importante

1. Índice de distúrbio respiratório (26,3 n_l /h) (VN= até 5 ng/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (70%);
3. Latência para o início do sono (3,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (57,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (94,1%) (VN= 85%);
6. Índice de despertares 14,0 ng/h (VN= até 15 n_l /h);
7. Percentual do estágio N1 (1,8%) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (48,7%) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (21,6%) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (27,9%) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;

Avaliação pela Dra Ana Cláudia - Sonofisio
Rua Santa Elza, 418 Vila Adyana São José dos Campos SP
Tel: (12) 3921 -1001

Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo
Neurologista e Neurofisiologista
CRM: 204.363 / SP
RQE: 79944



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code

Endereço: Ed. Helbor Offices - Av. São João, 2375 - Sala 1103 - Jardim das Colinas, São José dos Campos - SP,

Este documento não foi assinado eletronicamente. Para ser considerado válido, deve conter assinatura eletrônica ou impressão, carimbo e assinatura física.

Token (Farmácia): **596ZT6** - Código de desbloqueio (Paciente): **6939**

Clínica MS Cardiologia (SJC): Ed. Helbor Offices - Av. São João, 2375/1103 - Tel: (12) 99609-4879

Clínica Cardiofit (Jacarei) - R. Dom Pedro II, 84 - tel 12-39522527

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (26,3 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (70%);
3. Latência para o início do sono (3,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (57,0 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (94,1 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 14,0 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (1,8 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (48,7 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (21,6 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (27,9 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

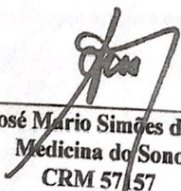
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: VALTER GONÇALVES

Data do Exame: 16-03-2025